

시형 관영 코멘트



쉽게 멍이 들어 내원하는 경우 혈소판 이상, 혈관 이상, 응고장애, 외상을 감별합니다. 출혈 경향이 있거나 현재 출혈이 있지는 않은지, 그에 따라 탈수 증상은 없는지 확인해야 합니다. 또한 약제에 의해 응고가 지연될 수 있기 때문에 약물 복용

용량도 성분까지 꼼꼼히 확인해야 합니다.

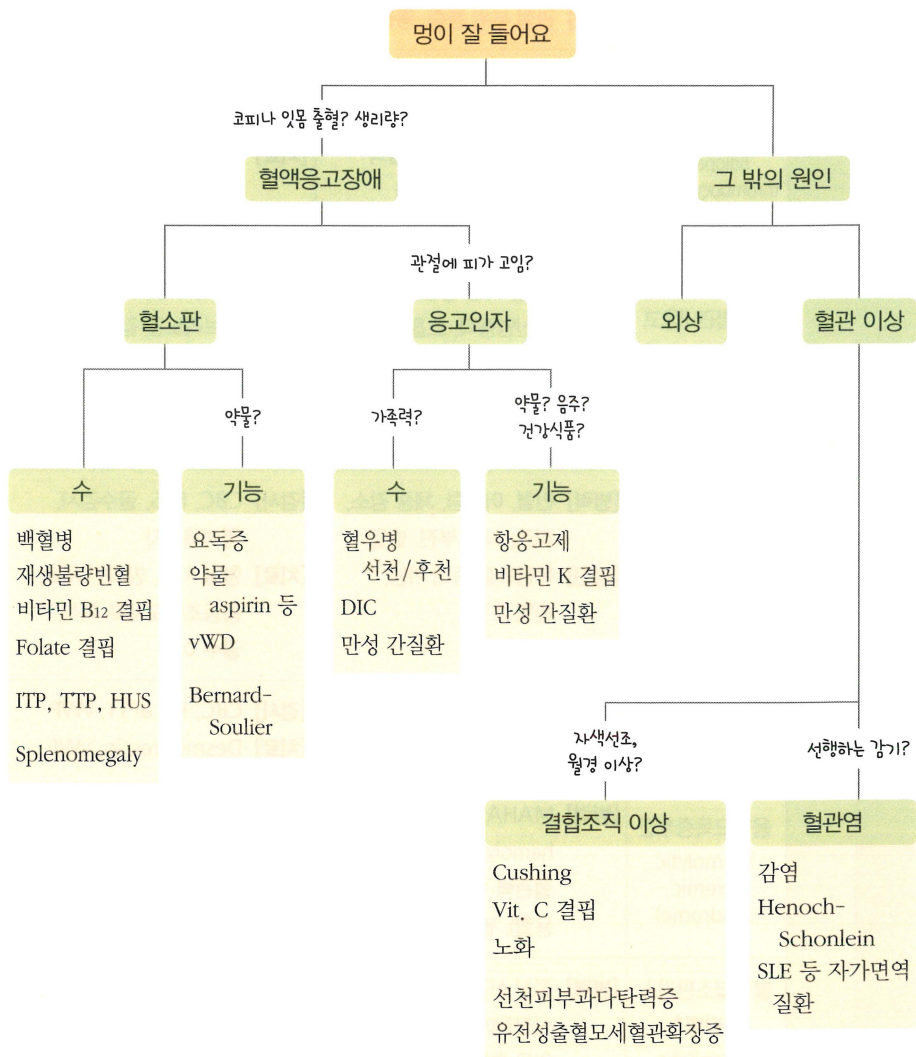
멍의 크기, 색, 누르면 하얗게 소실되는지, 통증 등을 자세히 물어보고, 신체 진찰에서도 멍을 자세히 시진하고 촉진하는 것이 필요합니다. 간/비장 진찰도 잊지 말고 시행해야 합니다.

흔히 출제되는 **특발혈소판감소자반병**의 경우 대개 특별한 치료 없이 호전됨을 알려주어 **안심시켜 주고**, 전기면도기 이용, 부드러운 칫솔 사용 등의 생활 습관에 대한 교육 또한 해주어야 합니다. 이 외에도 출혈이 심하거나 심한 두통, 시야장애, 혈변, 흑변 등의 증상이 나타나는 경우 즉시 병원에 내원하고, 수술이나 발치 시 의사와 반드시 상의하도록 교육하는 것이 중요합니다.

질병별 진단 / 치료 계획 정리

계통	원인	질병	진단 키워드	검사/치료
혈관	결합 조직 이상	쿠싱증후군 (cushing syndrome)	[병력] 자색선조, Moon face, Buffalo hump, 한약 복용, 월경 이상, 중심성 비만 [검진] 복부 자색선조, 중심성 비만	[검사] 덱사메타손 투여 후 코티솔 농도, 24시간 소변 코티솔 농도, ACTH 농도, 뇌 MRI [치료] 스테로이드 중단, TSA 뇌하수체절제술
	혈관염	헤노흐-쾨라인 자반병 (henoch-schonlein purpura)	[병력] 종아리 자색반, 복통, 구토, 관절통, 소아 호발 [검진] 주로 종아리 자색반	[검사] CBC, 소변검사, 필요 시 피부 생검 [치료] 스테로이드
혈액	응고 장애	간질환★ (간경화증, liver cirrhosis)	[병력] 황달, 복수, 음주력, 만성 간염 [검진] 눈, 피부 시진 시 황달, 복부 복수	[검사] LFT, 복부초음파 [치료] 항바이러스제, 인터페론
		비타민 K 결핍	[병력] 출혈 경향 [검진] 피부 시진 시 지반	[검사] PT, aPTT [치료] 비타민 K
		항응고제 복용	[병력] 항응고제 복용, 출혈 경향 [검진] 피부 시진 시 지반, 구강 점막의 출혈	[검사] PT, aPTT [치료] 와파린 : 비타민 K, 헤파린 : Protamine sulfate

혈액	응고 장애	혈우병 (hemophilia)	[병력] 남아, 어릴 때부터 잦은 코피, 관절 부위 통증, 부종 [검진] 관절 부위 통증, 종창	[검사] PT, aPTT, 응고인자검사, 항응고인자검사 [치료] 필요한 응고인자 투여
	혈소판 이상	특발혈소판감소 자반병★ (idiopathic thrombocytopenic purpura)	[병력] 피부 점상 출혈반, 잇몸이나 구강 내 출혈, 이전에 상기도 감염력 [검진] 전신 멍 든 곳 확인 (다른 것 배제)	[검사] CBC, PBS, PT, aPTT, 골수검사 [치료] 경과 관찰, 필요 시 수혈, 스테로이드, 면역 글로불린, 비장절제술
		파종혈관내응고 (disseminated intravascular coagulation)	[병력] 감염, 악성 종양 치료, 전신염증력, 호흡곤란, 두근거림 등의 쇼크 증상 [검진] 혈압 감소, 빈맥, 빈호흡	[검사] CBC, PT, aPTT, 피브리노겐 검사 [치료] [출혈 경향] 비타민 K, FFP, 수혈 [응고 경향] 항응고제, 항혈소판제
		골수 기능 저하 (백혈병, aplastic anemia)	[병력] 빈혈, 어지럼, 체중 감소, 피로, 식욕 부진, 발열 [검진] 목림프절 종대 가능, 빈혈 소견	[검사] CBC, PBS, 골수검사, 염색체검사 [치료] 항암 치료, 방사선 치료, 동종조혈모세포 이식, 골수 이식
		본빌레브란드병 (von willebrand disease)	[병력] 점상 출혈, 잇몸 출혈, 코 피, 과다월경	[검사] CBC, PT, aPTT, vWF [치료] Desmopressin, vWF
		용혈요독증후군 (hemolytic uremic syndrome)	[병력] MAHA(microangiopathic hemolytic anemia : fibrin 혈관벽 침착 → RBC 걸려 용혈), 핍뇨, 설사	[검사] 소변검사, BUN/Cr, PBS [치료] 보존적 치료, 혈액 투석, 수혈
		혈전혈소판감소 자반병★ (thrombotic thrombocytopenic purpura)	[병력] 정신 신경 증상, 발열, 신장장애, 점상 출혈, 잇몸 출혈	[검사] CBC, PBS, PT, aPTT, 골수검사 [치료] Plasmapheresis, 보존적 치료
정상 반응	외부 충격	외상	[병력] 외상 경험, 출혈반 [검진] X-ray 상 골절	[검사] X-ray [치료] 부목 고정, 드레싱



PEx

피부 탄력성	심장: 심잡음(endocarditis)
눈 결막 시진	복부: 자색선조, 간질환, 지라비대
인후 감염	

STEP 1 병력 청취

O	언제부터 멍이 잘 생겼나요?
L	처음 어디에 멍이 생겼나요?/멍이 주로 생기는 부위는 어디인가요? (피부 vs 관절) 지금은 어디에 멍이 있나요?
D	멍이 들면 얼마나 지속되나요?
Co	점점 커지나요? (10분 이상)/개수가 많아지나요?/멍이 점점 더 오래 가나요?
Ex	이전에도 멍이 잘 들었던 적이 있나요?/평소에도 멍이 잘 드시나요?
C	암기법 시진 상 특징 4개 + 감각 관련 + 멍 생성 기전/시간 [양상] [색] 색이 어떤가요? [크기] 크기는 어떤가요? [개수] 멍이 총 몇 개인가요? [창백 반응] 누르면 하얗게 되나요? [감각 관련] 통증, 가려움, 따가움, 감각 이상, 열감이 있나요? [멍 생성 기전/시간] 부딪히지 않더라도 멍이 생기나요? 부딪히고 어느 정도 지나서 멍이 생기나요? 일상 생활에 지장 있으신가요?
A	[전신] 발열/오한/체중 변화/피로 [출혈 경향] 코피/잇몸의 피/관절 부위 종창/생리량 과다/혈변/흑색변/토혈 [탈수-응급] 호흡곤란/식은땀/어지럼/두근거림 [LC] 황달/복수/부종이 있나요? [혈우병] 혈관절이 있나요? [TTP] 의식 저하/의식 소실/두통, 시야장애(CNS 증상)가 있었나요? [HUS] 소변량 감소/혈뇨 [ITP] 최근 감기/기침/가래/콧물/목아픔/객혈의 증상이 있었나요? [HSP] A/N/V/C/D/P/관절통이 있나요? [쿠싱] 자색선조/여드름/월경 이상이 있나요? 암기법 현혈한 사람에게는 간단한 현혈자용 특별 혜택 쿠폰을 줍니다. 설명 쉽게 멍이 드니까 수혈이 필요하겠죠? 현혈한 사람에게는 간단한 현혈자용 특별 혜택 쿠폰을 줍니다.

F	격한 운동을 많이 하시나요?
E	[건강 검진] 이전 건강 검진에서 이상 소견은 없었나요?
외	[외상] 외상을 입으시거나 어디 부딪히신 적 있으신가요? [수술] 과거 수술, 출산, 발치 시에 지혈이 잘 되었나요?
과	이전에 감기 걸린 적 있나요?/이전에 진단받은 병이 있나요? (간질환, 암, 빈혈)
약	현재 복용하시는 약물이 있나요? (스테로이드, NSAID, 헤파린, 와파린) 건강식품이나 한약은 드시나요?
사	술, 담배, 커피는 하시나요?/직업이 어떻게 되시나요?
가	가족 중에 혈우병/혈액암/간질환/유사 증상을 가진 분이 계신가요?
여	[월경] 월경은 규칙적으로 하시나요? 생리 주기는 얼마인가요? 월경량은 적당한가요? 월경통은 심하신가요? [임신] 임신 가능성이 있나요? 유산하신 적이 있나요? (사산 시 DIC 의심)
P/E	이제 신체 진찰을 하도록 할텐데요, 괜찮으신가요? 오늘 측정한 활력 징후는 정상입니다(이상 소견이 있는 경우 언급해 주기!). [앉아서] 1. 눈 : 결막(빈혈), 공막(황달) 2. 입 : 혀(탈수), 잇몸(출혈), 인후두(염증) 3. 목 : 림프절 비대, buffalo hump 4. 팔다리 ★ : 꼼꼼하게 멍 전부 확인하기 → 평평 or 융기, 눌러 보기 관절 → 운동성, 눌러 보기 저드랑이 림프절 비대 ⊕ 호흡기 증상이 명확한 경우, 흉부 진찰 : 흉부 시진/촉진/타진/청진 [누워서] 5. 복부 ★ : 시(중심성 비만, 자색선조)-청-타(간, 비장 종대, 복수)-촉(간, 비장) 6. 사지 : 하지 부종, 피부 긴장도
술기	[임상 술기] 모형이 준비되어 있음 1. 안전 수혈 술기 → 협조해 주셔서 감사합니다. 불편한 점은 없으신가요?

STEP 2 환자 교육

공감	쉽게 멍드는 증상이 갑자기 발생하여 많이 걱정이 되셨을 텐데요,
추정 진단	지금까지의 문진과 신체 검진을 종합해 보았을 때 가장 의심되는 질환은 특발혈소판감소자반병입니다. 이 질환은 혈소판의 기능 이상으로 출혈이 생겨 멍이 쉽게 들 수 있는 질환입니다.
감별 진단	하지만 이 외에도 혈소판 이상을 일으킬 수 있는 다른 질환도 완전히 배제할 수 없습니다.
검사	따라서 정확한 진단을 위해 기본 혈액검사인 전혈구검사와 혈액응고시간검사, 말초혈액도말검사를 시행하고자 합니다. 괜찮으신가요?
치료	만약 검사 후에도 이 질환으로 진단이 되면 혈소판의 수치에 따라 스테로이드나 면역 글로불린 등의 치료가 필요할 수 있습니다. 하지만 대부분의 경우에는 감기 증상 후 일시적으로 발생하는 증상이므로 크게 걱정하실 필요는 없습니다.
예후	지금부터 잘 치료를 받으시면 호전되실 수 있습니다. 증상이 있을 때 병원에 잘 오셨습니다.
교육	[출혈 위험 예방 교육] ① 외부 활동 자제, 외상 유발 상황 피하기 : 양치질 부드럽게, 코 살짝 풀기, 전기면도기 사용하기, 격한 운동 피하기 ② 출혈 심할 때 바로 내원 : 멍이 계속 커짐, 코피 안 멎음, 토혈/객혈, 혈변/흑색변, 어지럼, 호흡곤란 ③ 수술이나 발치 필요 시 의사와 반드시 상의 ④ 약물 복용 시 주의
질문	마지막으로 혹시 궁금한 점이 있으신가요?

❖ 기본적 진단 계획

- ① 혈액검사 : CBC, LFT
- ② ITP, TTP : 응고 시간 측정(Bleeding time, aPTT, PT), 응고인자검사
- ③ Cushing : 야간 텍사메타손 부하검사
- ④ Liver disease : 간기능검사, 간초음파검사, 복부 CT
- ⑤ Leukemia : 말초혈액도말검사, 골수검사

❖ 치료 계획

- ① ITP : glucocorticoid → IVIG(면역 글로불린) → splenectomy
- ② TTP : plasmapheresis(혈장분리교환술), 면역억제제, FFP(fresh frozen plasma)
- ③ 혈우병 : 응고인자 보충(factor 8, 9 concentrate), cryoprecipitate(혈우병 A)

❖ 환자 안내/생활 습관 교육(출혈 위험 예방 교육)

- ① ITP일 확률이 높은 경우 일시적으로 그럴 수 있다고 하면서 환자를 안심
- ② 출혈이 쉽게 일어나고 잘 멎지 않으므로 상처를 입지 않도록 하고, 특히 노인 환자의 경우 두개강 내 출혈의 위험성이 더 높으므로 주의해야 함을 강조
- ③ 심한 두통, 시야장애, 혈변, 흑변 등 위급한 증상이 보이면 바로 병원 오기
- ④ 아스피린 및 진통소염제 등의 약제는 혈소판 기능을 저하시키는 부작용이 있어 혈소판감소증이 있는 환자가 복용하는 경우 출혈 경향을 더욱 증가시킬 수 있으므로 가급적 사용하지 않도록 한다.
- ⑤ 발치 등의 시술이나 수술 전에는 의사와 반드시 상의
- ⑥ 전기면도기 이용, 부드러운 칫솔 사용, 과도한 운동이나 야외 활동 금지 등의 생활 습관에 대한 교육



keyword

출혈 유무를 확인하고, 있다면 출혈의 정도(탈수 증상 등)를 확인하기
멍의 크기, 색, 통증, 눌렀을 때 하얗게 소실되는지 등 특징에 대해 자세히 문진하기
신체 진찰 : 문진 내용 직접 확인하기, 간/ 비장 신체 진찰 시행하기
특발혈소판감소자반병은 대부분 경과 관찰을 요하기에 환자 안심시키기
외상 유발 상황 피하고, 출혈이 심할 경우 즉시 병원에 내원하고, 수술이나 발치 시
의사와 반드시 상의하도록 교육하기